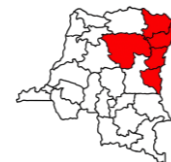




TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17^{ème} Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°110/MVEBDB/01/09/2026

Date de rapportage : 01 septembre 2026

Date de publication : 02 septembre 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

Au cours des dernières 24h, 64 nouveaux cas confirmés dont 25 décès communautaires de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été enregistrés dans les provinces de l'Ituri (39 cas), du Nord-Kivu (20 cas), Haut Uélé (4) et (1) à la Tshopo. De plus, 7 décès intra-CTE ont été enregistrés.

Aucune nouvelle zone de santé touchée au cours de dernières 24h avec une notification globale en recul (-25,6%)

CUMUL DES CAS

6 250

CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS

3 039

LETALITE

48,6%

PATIENS EN ISOLEMENT/CTE

869

CUMUL DES GUÉRIS

1 439

TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour)

89,0 %



Provinces touchées et Zones de santé touchées



6 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé



60 Zones de santé touchées sur 151 (39,7%)



Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures

En date du 01 septembre 2026, **64 nouveaux cas confirmés** dont **25 décès communautaires** de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été notifiés dans les provinces de l'Ituri (39 cas), Nord-Kivu (20), Haut Uélé (4) et (1) à la Tshopo. Parallèlement, **7 décès intra-CTE** ont été enregistrés, dont 6 en Ituri et 1 au Haut Uélé, portant **le nombre des décès du jour à 32**.

Cependant, **30 patients** ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE (27 en Ituri, 2 au Nord-Kivu et 1 à la Tshopo).

Cumulativement, la RDC compte **6 250 cas confirmés** dont **3 039 décès**, soit une létalité de **48,6 %**. La province de l'Ituri demeure l'épicentre avec **81,7 %** des cas confirmés enregistrés au pays et détient **60,9 %** des nouveaux cas confirmés rapportés au cours des dernières 24h.

Depuis le début de l'épidémie en RDC, **60 zones de santé sur 151 (39,7%)** restent affectées à travers les six provinces touchées. L'Ituri compte 28 zones de santé touchées sur 36, suivi du Nord-Kivu (15/34) du Haut-Uélé (6/13), de la Tshopo (7/23), du Sud-Kivu (1/34) et Bas Uélé (3/11).

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 01 septembre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	39	5104	2 324	45,5%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	20	888	601	67,7%	15/34 (44,1 %)
Haut-Uélé	4	231	101	43,7%	6/13 (46,1 %)
Tshopo	1	20	9	45,0%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas Uélé	0	4	3	75,0%	3/11(27,3%)
Total	64	6 250	3 039	48,6%	60/151 (39,7 %)

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone de santé, au 01 septembre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	5104	2324	45,5%	39	13	6	19
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	165	36	21,8%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1413	442	31,3%	6	1		1
Damas	28	9	32,1%				0
Drodro	14	7	50,0%				0
Fataki	77	30	39,0%	1	0		0
Gethy	6	2	33,3%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	32	12	37,5%				0
Komanda	92	62	67,4%	5	3		3
Lita	224	121	54,0%	4	2		2
Logo	11	5	45,5%				0
Lolwa	22	5	22,7%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	17	7	41,2%				0
Mandima	36	21	58,3%				0
Mangala	263	134	51,0%	6	1		1
Mongbwalu	615	287	46,7%	3	1		1
Nia-Nia	216	113	52,3%				0
Nizi	670	264	39,4%	6	3		3
Nyankunde	124	35	28,2%				0
Rimba	11	4	36,4%	1	0		0

Rwampara	964	341	35,4%	7	2		2
Tchomia	57	25	43,9%				0
A ventiler	NA	345	NA	NA	NA	6	6
Nord-Kivu	888	601	67,7%	20	12	0	12
Beni	146	105	71,9%	5	3		3
Biena	1	1	100,0%				0
Butembo	180	134	74,4%	6	3		3
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	16	7	43,8%				0
Katwa	408	270	66,2%	4	2		2
Kyondo	16	12	75,0%				0
Lubero	3	3	100,0%	1	1		1
Mabalako	6	5	83,3%	1	1		1
Manguredjipa	2	1	50,0%	1	1		1
Masereka	11	5	45,5%	2	1		1
Musienene	83	47	56,6%				0
Mutwanga	2	2	100,0%				0
Oicha	7	6	85,7%				0
Vuhovi	6	3	50,0%				0
Haut-Uélé	231	101	43,7%	4	0	1	1
Boma Mangbetu	27	14	51,9%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	85	34	40,0%	4	0	1	1
Pawa	37	22	59,5%				0
Rungu	1	0	0,0%				0
Wamba	78	30	38,5%				0
Tshopo	20	9	45,0%	0	0	0	0
Bafwasende	2	0	0,0%				0
Kabondo	3	1	33,3%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	9	5	55,6%				0
Mangobo	3	2	66,7%	1	0		0
Tshopo	1	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	4	3	75,0%	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	1	0	0,0%				0
Ganga	2	2	100,0%				0
Total	6250	3039	48,6%	64	25	7	32

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province et sont en cours de ventilation pour être classifié par zone de santé.

NA : Non Applicable.

** Ces décès ont été enregistrés dans les différents CTE de la province de l'Ituri et sont en cours de ventilation.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province, au 01 Septembre 2026

DPS	Nouvelles Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	12	2	14	12	1	0	0	13	10
Bas Uélé	25	0	25	4	0	21	0	4	0
Ituri	803	74	877	142	74	626	0	216	125
Nord-Kivu	608	42	650	70	38	501	4	108	50
Sud-Kivu	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Tshopo	138	1	139	6	1	132	0	7	1
Total Général	1586	119	1 705	234	114	1280	4	348	186

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours

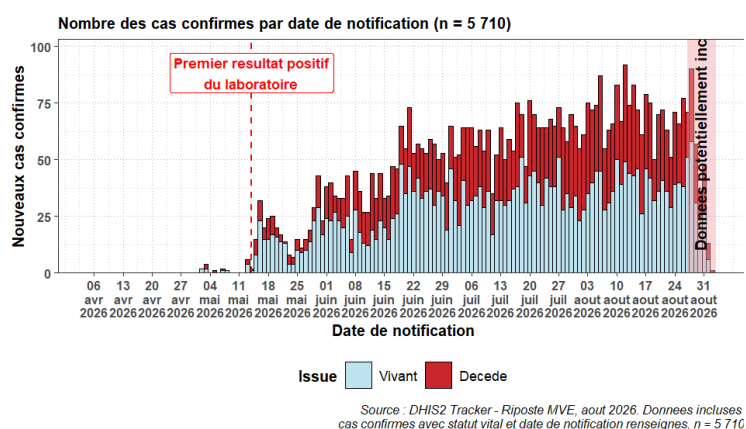
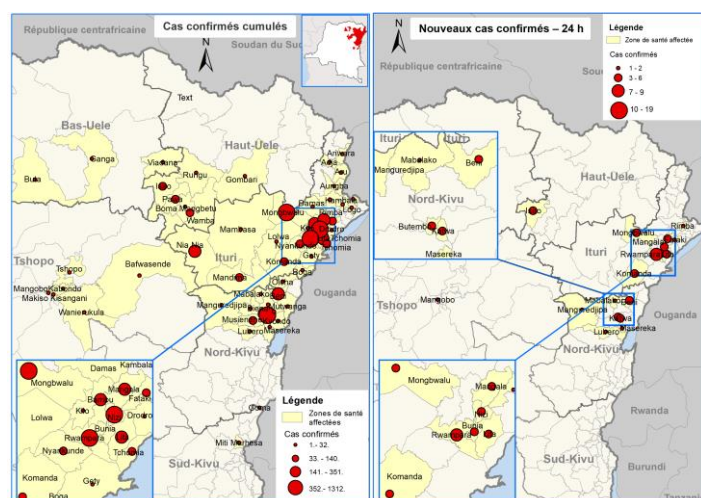


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24h et cumuls) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Suivi et accompagnement des actions de la réponse dans toutes les provinces touchées.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

1.1.1. Surveillance épidémiologique

1.1.2. Principales Actions

Au cours des dernières 24h, 1705 alertes ont été enregistrées dans les 6 provinces touchées, 1 632 (95,7%) ont été vérifiées. Ainsi, 348 alertes ont été validées comme cas suspects. Ces derniers ont tous été investigués (100 %) et 186 d'entre eux ont été transférés vers les CT/CTE (Tableau 3).

La proportion des contacts suivis au cours des dernières 24 heures se situe à 89,0 % (16 719 vus sur 18 784 à suivre), supérieure au seuil de 85 %, comparativement à la veille (88,0%) ; 100 % à la Tshopo (350/350), 90,1% au Nord-Kivu (7 468/8 293), 89,7% en Ituri (7 115/ 7 932), 84,6% au Haut Uélé (1 562/1 846) et 61,7% au Bas Uélé (224/363).

1.1.3. Défis

Persistance d'un faible suivi des contacts autour des cas confirmés dans la province du Bas Uélé, lié à une insuffisance des équipes dédiées à ces activités.

1.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoC/PoE)

1.2.1. Principales actions

Six (06) alertes vivantes ont été notifiées aux PoE/PoC au cours des dernières 24 heures, dont cinq validées et référées : deux en Ituri, au PoC d'Iga-Barrière (ZS Nizi) et au PoC d'Irumu Centre (ZS Nyankunde), tous deux isolés et référés aux CTE de Bunia et de Nyankunde ; quatre au Nord-Kivu dont trois validées, tous référés dans les structures dédiées.

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoC/PoE par province, en date du 01 Septembre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Bas-Uélé	Global
Complétude des rapports	96,0 % (58/60)	100 % (18/18)	55,5 % (5/9)	76,47% (13/17)	54,5 % (4/11)	80% (12/15)	79,13 % (91/115)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	9,09 % (1/11)			100% (17/17)			9,1 % (1/11)
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	145990	88249	6 609	3 981	15 539	6091	266 459
% des voyageurs screenés	99,00%	96,83%	98,00%	99,90%	98,30%	98,16%	98,41%
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,90%	96,83%	98,00%	99,30%	96,00%	98,16%	97,61%
% des voyageurs sensibilisés	99,50%	96,83%	100%	100%	96,60%	98,16%	98,59%
Nombre d'alertes notifiées	2	4	0	0	0	0	6
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	2	3	0	0	0	0	5
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	0	0	0	0	0
% des cas suspects transférés au CT/CTE	100%	100%	100%	100%	0%	-	100%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	0%	0%	ND	100%	0%	-	0%
% des cas suspects investigués dans 24 h	100%	100%	100%	ND	0%	-	100%

1.2.2. Défis

Opérationnalisation des PoE/PoC non optimale et faible complétude de rapportage au Sud-Kivu (55,5 %) et au Haut-Uélé (54,5 %) ; En Ituri, 1 (9,09 %) des 11 PoE/PoC stratégiques demeure fonctionnel sans interruption : le PoC d'Avakubi est non fonctionnel pour raisons sécuritaires, les PoC Nzebi, Pont Ituri, Makoko 2 et Foner Mambasa sont en grève faute de paiement. Au Haut-Uélé, 4 PoC (Dusu, Apodo, PK10 route Poko et Gossamu) n'ont pas rapporté et le PoC de Magambe enregistre de refus de screening (3 %) et de lavage des mains (13 %). Au Sud-Kivu, absence de dispositif d'isolement aux PoE de Kavimvira, Kalundu Port SNCC et Baraka demeure.

1.3. Laboratoire

1.3.1. Principales actions

- **Ituri : 39 nouveaux résultats positifs** (26 vivants et 13 décès) sur 347 nouveaux échantillons reçus et analysés (**positivité : 11,2 %**).

- **Nord-Kivu :20 nouveaux résultats positifs** (8 vivants et 12 décès) sur 110 échantillons analysés (**positivité de 18,1%**).
- **Haut-Uélé : 4 nouveaux résultats positifs** (3 vivants et 1 décès) sur 26 échantillons analysés (**positivité : 15,3%**).
- **Bas-Uélé : 1 échantillon** reçu et testé (1 sang), est revenu négatif.
- **Tshopo** : Dotation des équipements (1 imprimante Epson, 3 Split 12 000 BTU), Classeurs, Stylo, Marquer, papier duplicateur, cartouches pour imprimante ; briefing des agents de morgue et EDS sur le prélèvement SWAB.

1.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

1.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 19 rings ont été ouverts sur les 45 identifiés (42,2 %), 113 ménages décontaminés sur 116 identifiés (97,4 %) et 13 FOSA sur 13 (100 %) ; 77 EDS réalisées sur 126 alertes et 65 corps swabés (42 échecs).
- **Au Nord-Kivu**, 10 rings ouverts sur 30 (33,3 %), 6 ménages décontaminés sur 21 identifiés (28,6 %) et 21 FOSA décontaminées sur 28 (75 %) ; 6 évaluations FOSA réalisées avec un score moyen de 29 %. D'autre part, 51 corps swabés et 59 EDS réalisés.
- **À la Tshopo**, Décontamination de 6 locaux, 1 latrine et 1 douche de PEKIS (17^e cas); suivi et accompagnement de 11 ESS dans 5 ZS (Makiso-Kisangani, Mangobo, Tshopo, Kabondo et Lubunga) dont 116 prestataires ont été briefés sur la mise en œuvre des mesures PCI ; décontamination de 6 locaux, 1 latrine et 1 douche à PEKIS et mise en place d'un système de dépistage et de triage à l'HGR Bafwasende.

1.4.2. Au Bas-Uélé, 4 rings ouverts sur 4 (100 %), 2 ménages décontaminés sur 2 identifiés (100 %) et 1 FOSA sur 1 (100 %) ; 1 évaluation FOSA à Buta.

1.4.3. Défis

- Faible mise en œuvre des normes de PCI : en Ituri, l'ouverture des rings demeure faible (42,2 %) ; insuffisance d'équipes de décontamination à Fataki, Mangala et Nizi. Au Nord-Kivu, seuls 6 ménages ont été décontaminés sur 21 identifiés (28,6 %). À la Tshopo, insuffisance d'intrants PCI dans les ESS et panne de l'incinérateur de l'HGR Makiso-Kisangani

1.5. Prise en charge holistique

1.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 112 nouvelles admissions dans les différentes structures dédiées contre 87 sorties dont 27 guéris. Ainsi, 564 patients sont hospitalisés pour 978 lits, soit un taux d'occupation de 57,7 %.
- **Au Nord-Kivu**, 60 nouvelles admissions et 62 sorties dont 2 guéris ; 232 patients sont hospitalisés et le taux d'occupation global des lits en CTE/CT est en sursaturation (105,5 % ; 232/220).
- **Au Sud-Kivu**, aucune nouvelle admission n'a été enregistrée. Huit (8) patients sont en isolement pour 25 lits, soit un taux d'occupation global de 32,0%.
- **Au Haut Uélé**, 11 nouvelles admissions ont été enregistrées. Au terme de la journée, 62 patients, soit un taux d'occupation global de 51,7% (120 lits).
- **À la Tshopo**, une nouvelle admission a été enregistrée contre 3 sorties dont 1 guéri. Trois (3) patients sont en isolement pour 25 lits, soit un taux d'occupation global de 12,0%.

1.5.2. Défis

Faible capacité d'accueil et saturation : en Ituri, les CTE de Bambu (confirmés) et de Nizi (suspects) ainsi que les CT de Kigonze et Lolwa (suspects) sont saturés ; au Nord-Kivu, sursaturation de certains CT/CTE ; Nord-Kivu.

1.6. Communication sur les risques et engagement communautaire

1.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, 12 personnes informées sur l'importance du suivi de contact et adhésion aux actions de riposte ; 55 personnes sensibilisées sur l'importance des actions PCI ; 15 personnes informées et sensibilisés sur l'importance de l'adhésion aux actions PCI et le suivi régulier des contacts dans la zone de santé de Rwampara.
- **Au Nord-Kivu**, 14 794 visites à domicile ont été réalisées touchant 45 772 personnes ; 77 causeries éducatives réalisées avec 1 949 personnes ; 3 communications de masse (459 personnes) et 4 briefings (153 personnes) ; 8 feedbacks et infodémies résolus dans les 48 heures sur 8 captés et 150 alertes notifiées par les acteurs communautaires ; briefing de 35 tenanciers de pharmacie à Musienene.
- **À la Tshopo**, 1 289 personnes sensibilisées (696 femmes et 593 hommes) ; 2 rumeurs clarifiées et 2 feedbacks communautaires recueillis ; 302 dépliants et 58 affiches distribués ; sensibilisation des promoteurs des écoles privées de Kisangani et poursuite des visites à domicile dans les ZS de Kabondo et Lubunga.
- **Au Bas-Uélé**, sensibilisation de plus de 200 personnes lors du deuil d'un cas positif au village Bobagata (AS Mabodho, ZS Ganga), briefing de 30 acteurs de presse à Buta et dialogue communautaire dans l'AS Eganda (ZS Bondo), avec l'appui de FHI360.

1.6.2. Défis

Persistance des défis au niveau communautaire : en Ituri, 17 refus d'isolement au CTE, 42 corps non swabés pour résistance communautaire et résistances à Bambu, Mandima et Fataki ; à la Tshopo, résistances aux investigations, aux prélèvements, à l'isolement et au transfert au CTE.

1.7. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

1.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, 17 personnes parmi les nouveaux cas confirmés et 159 des 209 cas confirmés en cours de suivi (76 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 53 des 112 nouveaux suspects (47,3%) ; 77 ménages accompagnés, 41 PPL soutenus, 74 annonces de résultats dont 17 positifs et 14 guéris sur 16 suivis en communauté (87,5 %).
- **Au Nord-Kivu**, 28 nouveaux cas confirmés et 132 des 167 cas suspects ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 103 des 123 annonces de résultats réalisées dont 31 positifs, 58 PPL soutenus et 45 ménages accompagnés. À la Tshopo, 1 cas confirmés et 2 Cas suspects en cours de suivi 3 annonces de résultats et 2 accompagnants soutenus au CT ; 2 guéris ont intégré les équipes de riposte.
- **Au Bas-Uélé**, 2 résultats de laboratoire annoncés dont 1 positif et 3 PPL ont bénéficié d'interventions SMSPS.

1.7.2. Défis

En Ituri, faible couverture des interventions SMSPS autour des derniers cas confirmés ; couverture limitée à 6 des 10 ZS ayant notifié (60,0 %). À la Tshopo, absence de prestataires SMSPS dans les ZS de Wanie-Rukula et Bafwasende.

1.8. Logistique

1.8.1. Principales actions

- **Dans la Tshopo**, suivi de l'évolution de la construction des isolements de Madula et d'un CTE de grande capacité ; dispatching des motos aux différents piliers ; appui à la mobilité

des piliers PCI, PECH, Communication, PoE/PoC et vaccination ; déballage et actualisation des stocks.

- **En Ituri**, livraison d'intrants PCI à la ZS de Mangala et de 3 570 kg de vivres (1 922 colis) à la ZS de Tchomia, don de Save the Children.
- **Au Nord-Kivu**, livraison d'intrants PCI au pilier mitigation et sécurité et mission de visite des CTE de Katwa et Beni avec l'OMS et le PAM.

1.8.2. Sécurité

1.8.3. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, 12 activités de maintien de la discipline populaire ont été réalisées, dont l'accompagnement sécuritaire des équipes PCI pour les décontaminations à Beni (AS Malepe, Ndindi, Mangote et Ngongolio) et des équipes EDS à Katwa (AS Kivika, Mukuna et Kangote).

1.8.4. Défis

Persistence des évasions dans les CT/CTE : 2 évasions de cas suspects ont été enregistrées à Mangala (Ituri), les patients ayant quitté l'hôpital de nuit. Au Nord-Kivu, résistance des officiels au respect du protocole sanitaire aux PoC et sécurisation renforcée du PoC de Vulindi (ZS Butembo).

1.9. PSEA (Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels)

1.9.1. Principales actions.

En Ituri, briefing de 97 personnes dont 76 ont été formés sur la prévention contre les exploitation, abus et harcèlement sexuel dans la zone de santé de Bunia et 21 personnes dans la zone de santé de Nizi ; poursuite avec l'affichage des messages et distribution des dépliants PSEAH dans les ZS de Bunia, Aru, Rwampara, et Mongwalu.

1.9.2. Défis

- Couverture encore insuffisante des activités PSEA : 25 % des zones de santé de l'Ituri (9/36) connaissent le mécanisme de signalement ; absence de cartographie des intervenants ; insuffisance de supports de sensibilisation de masse ; manque de moyens de transport et d'équipement informatique pour le pilier.

MESSAGES CLES

- Au terme de cette journée, un maintien des performances a été observé dans les investigations épidémiologiques (**100 % des cas suspects investigués**) et une stabilité sur la proportion journalière du suivi des contacts **89,0% vs 88,0% la veille**.
- La transmission continue de la MVE, avec **64 nouveaux cas confirmés** dont **25 décès communautaires et 7 intra-CTE** enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le cumul national à **6 250 cas confirmés et 3 039 décès**.
- L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 81,7 % des cas confirmés cumulés et 60,9% des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures, suivi de la province du Nord-Kivu qui affiche la létalité la plus élevée.
- Le renforcement des interventions prioritaires (surveillance, prise en charge, PCI, logistique et engagement communautaire) demeure essentiel pour interrompre rapidement les chaînes de transmission.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr Kombe NGWAMA John

Equipe rédaction

Professeur Dr Mulangu Katulumba Félix-Médard

Dr Katusi Biselenge Jules

Madame Mayele Afua Marie

Dr Diur Mananashi Floryan

Mr Kamuina Kebela John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd